

Dolor muscular local, mioespasmos y dolor miofascial

Tema 8 · Trastornos musculares

Panorama

Los trastornos musculares son la causa **más frecuente** de dolor en el sistema masticatorio, por encima de los articulares. Los tres cuadros del programa son:

- **Dolor muscular local**
- **Mioespasmo**
- **Dolor miofascial**

Se distinguen por la duración, la presencia de contracción y la existencia de puntos gatillo. Diferenciarlos importa porque el manejo cambia.

Dolor muscular local

Es la respuesta inicial del músculo a una sobrecarga o a un traumatismo. Corresponde a una mialgia no inflamatoria.

Características:

- Dolor **a la palpación** del músculo afectado
- Aumenta con la función y disminuye con el reposo
- Puede haber leve limitación de apertura
- **No** hay puntos gatillo ni dolor referido
- Es de instalación reciente

Es el cuadro de mejor pronóstico. Suele ceder retirando la causa y con manejo conservador.

Mioespasmo

Contracción **involuntaria, súbita y sostenida** del músculo, de origen en el sistema nervioso central.

Características:

- Inicio **brusco**
- Limitación **marcada** de la apertura
- Músculo firme y doloroso a la palpación
- Puede haber cambio agudo en la oclusión, porque el músculo contraído desplaza la mandíbula
- Duración corta, de horas a días

Es el que más asusta al paciente por lo repentino. Un mioespasmo del pterigoideo lateral inferior produce mordida abierta posterior del lado contrario.

Dolor miofascial

Es un dolor muscular **regional y crónico** caracterizado por la presencia de **puntos gatillo**: bandas tensas dentro del músculo que, al palparse, reproducen un dolor **referido** a distancia.

Características:

- Evolución prolongada
- Dolor referido con patrón reproducible
- Sensación de fatiga y rigidez
- Frecuentemente asociado a estrés y a alteraciones del sueño

Lo que lo define y lo distingue de los otros dos es el **punto gatillo con dolor referido**.

Dolor referido

Es dolor que se percibe en un sitio **distinto** de donde está el origen. Explica muchos diagnósticos equivocados.

Patrones frecuentes:

- **Masetero** → dientes posteriores, oído, región mandibular
- **Temporal** → región temporal, dientes superiores, detrás del ojo
- **Esternocleidomastoideo** → cara, oído, región frontal
- **Pterigoideo lateral** → región del seno maxilar y ATM

De ahí la advertencia clásica: hay pacientes tratados endodónticamente por un dolor que era del masetero. Palpa antes de instrumentar.

Cómo palpar

Presión firme y constante, aproximadamente 1 a 2 kg, sostenida entre 2 y 5 segundos, y siempre bilateral para comparar.

Músculos a explorar:

- **Masetero**: superficial y profundo, extraoral
- **Temporal**: haces anterior, medio y posterior
- **Pterigoideo medial**: intraoral, cara interna de la rama
- **Esternocleidomastoideo y trapecio**: cervicales, se exploran porque refieren a la cara

Registra si hay dolor, si hay dolor referido y a dónde refiere. Esa última parte es la que orienta el diagnóstico.

Manejo

Siempre empezando por lo reversible:

- **Educación**: explicar el cuadro, retirar hábitos, dieta blanda temporal

- **Termoterapia** y ejercicios de estiramiento controlado
- **Férula oclusal** de estabilización
- **Fisioterapia**
- **Farmacológico**: analgésicos, relajantes musculares en cuadros agudos
- **Manejo del estrés** y del sueño, que suelen ser el motor de fondo

Solo después, y con diagnóstico firme, se plantea terapia irreversible. La toxina botulínica es coadyuvante, no primera línea.

Este material también está disponible en la plataforma, con ejercicios de autoevaluación por niveles y el asistente académico. dentipedia.dentilike.com.mx